mélanome

Niveau : DES
Genere le 13 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Traitement

Traitement du Mélanome

Le traitement du mélanome est une prise en charge complexe et multidisciplinaire, dont les modalités dépendent principalement du stade de la maladie au moment du diagnostic. L'objectif principal est l'éradication de la tumeur primaire, la prévention des récidives locorégionales et des métastases à distance, ainsi que l'amélioration de la survie globale et de la qualité de vie des patients. La stratégie thérapeutique est guidée par les classifications internationales (AJCC) et les caractéristiques biologiques de la tumeur.

Exérèse Chirurgicale

La chirurgie représente la pierre angulaire du traitement du mélanome, qu'il soit *in situ* ou invasif (Dermatologie, 2022). L'exérèse chirurgicale doit être réalisée en deux temps distincts :

Exérèse Diagnostique

La première étape consiste en une exérèse complète de la lésion suspecte, idéalement par une biopsie excisionnelle, avec des marges minimales (1 à 2 mm) pour permettre une analyse anatomopathologique précise. Cette analyse est cruciale pour confirmer le diagnostic de mélanome et déterminer ses caractéristiques histologiques, notamment l'épaisseur de Breslow, l'indice mitotique, la présence d'ulcération, l'invasion lymphovasculaire et la régression. Ces éléments sont essentiels pour la stadification et l'orientation thérapeutique ultérieure (Dermatologie, 2022). L'analyse anatomopathologique est une étape indispensable après toute exérèse chirurgicale d'une lésion cutanée suspecte (Dermatologie, 2022).

Exérèse Thérapeutique (Reprise Chirurgicale)

Une fois le diagnostic de mélanome confirmé et ses caractéristiques établies, une seconde intervention chirurgicale est généralement nécessaire pour réaliser une exérèse plus large, visant à obtenir des marges de sécurité adéquates autour de la cicatrice de la biopsie initiale. Les marges recommandées dépendent de l'épaisseur de Breslow du mélanome primaire :

- Mélanome *in situ* : 0,5 cm de marge.
- Mélanome invasif avec épaisseur de Breslow ≤ 1 mm : 1 cm de marge.
- Mélanome invasif avec épaisseur de Breslow > 1 mm et ≤ 2 mm : 1 à 2 cm de marge.
- Mélanome invasif avec épaisseur de Breslow > 2 mm : 2 cm de marge.

Cette exérèse large est fondamentale pour minimiser le risque de récidive locale, compte tenu de l'agressivité locorégionale potentielle du mélanome (Dermatologie, 2022).

Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

La biopsie du ganglion sentinelle est une procédure de stadification essentielle pour les mélanomes invasifs à risque de dissémination ganglionnaire (généralement ceux avec une épaisseur de Breslow > 0,8 mm ou ceux ulcérés quelle que soit l'épaisseur). Elle consiste à identifier et à exciser le premier ganglion lymphatique drainant le site du mélanome primaire. L'analyse histologique de ce ganglion permet de détecter la présence de micrométastases. Un ganglion sentinelle positif est un facteur pronostique majeur et indique un risque élevé de métastases à distance, orientant vers des traitements adjuvants (Dermatologie, 2022). Le mélanome présente un risque local et métastatique significatif, affectant en premier lieu le territoire de drainage ganglionnaire, puis les sites viscéraux, notamment pulmonaires et hépatiques (Dermatologie, 2022).

Traitements Systémiques pour le Mélanome Avancé ou Métastatique

Pour les mélanomes de stade avancé (stade III avec envahissement ganglionnaire important ou stade IV avec métastases à distance), les traitements systémiques sont indispensables en raison du risque élevé de dissémination (Dermatologie, 2022). Les avancées thérapeutiques de la dernière décennie ont révolutionné la prise en charge de ces formes, avec l'émergence des thérapies ciblées et des immunothérapies.

Thérapies Ciblées

Les thérapies ciblées sont indiquées chez les patients dont la tumeur présente des mutations spécifiques, notamment la mutation BRAF V600. Environ 40 à 50 % des mélanomes cutanés sont porteurs de cette mutation. Les inhibiteurs de BRAF (par exemple, vemurafenib, dabrafenib, encorafenib) agissent en bloquant l'activité de la protéine BRAF mutée, essentielle à la prolifération cellulaire tumorale. Ils sont souvent associés à des inhibiteurs de MEK (par exemple, cobimetinib, trametinib, binimetinib) pour améliorer l'efficacité et réduire la toxicité.

Ces traitements peuvent entraîner des effets indésirables spécifiques. Par exemple, une photosensibilité est fréquemment observée sous anti-BRAF, pouvant se manifester par un érythème phlycténulaire localisé, notamment sur les zones exposées comme la face dorsale des orteils après le port de chaussures ouvertes (Dermatologie, 2022). D'autres effets secondaires incluent la fièvre, les arthralgies, les éruptions cutanées (non liées à la photosensibilité), la kératoacanthome/carcinome épidermoïde cutané, et des troubles hépatiques.

Immunothérapies

L'immunothérapie représente une avancée majeure dans le traitement du mélanome avancé, indépendamment du statut mutationnel BRAF. Elle vise à restaurer ou à renforcer la réponse immunitaire anti-tumorale du patient. Les principales classes d'immunothérapies utilisées sont les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (checkpoint inhibitors) :

- **Anti-PD-1 (Programmed Death-1)** : Le pembrolizumab et le nivolumab bloquent la liaison de PD-1 à ses ligands (PD-L1 et PD-L2), levant ainsi l'inhibition des lymphocytes T anti-tumoraux.
- **Anti-CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4)** : L'ipilimumab bloque CTLA-4, une molécule régulatrice négative de l'activation des lymphocytes T, favorisant ainsi une réponse immunitaire plus robuste.
- **Combinaisons** : L'association d'anti-PD-1 et d'anti-CTLA-4 (par exemple, nivolumab + ipilimumab) est souvent utilisée pour les mélanomes les plus agressifs, offrant des taux de réponse plus élevés mais avec une toxicité accrue.

Les effets indésirables de l'immunothérapie sont de nature auto-immune et peuvent affecter divers organes : cutanés (rash, prurit), gastro-intestinaux (colite), endocriniens (thyroïdite, hypophysite), hépatiques (hépatite), pulmonaires (pneumonite), et neurologiques. Leur gestion nécessite une expertise spécifique.

Chimiothérapie

Historiquement, la chimiothérapie (par exemple, dacarbazine) était le traitement standard du mélanome métastatique. Cependant, avec l'avènement des thérapies ciblées et des immunothérapies, son rôle est devenu très limité, réservé aux situations où les autres options sont épuisées ou contre-indiquées, en raison de son efficacité modeste et de sa toxicité non spécifique.

Traitements Adjuvants et Néo-adjuvants

Traitement Adjuvant

Le traitement adjuvant est administré après l'exérèse chirurgicale complète du mélanome, dans le but de réduire le risque de récidive chez les patients à haut risque (mélanomes de stade IIB/C et de stade III). Les options adjuvantes incluent l'immunothérapie (anti-PD-1) ou les thérapies ciblées (inhibiteurs de BRAF/MEK pour les mélanomes mutés BRAF). Ces traitements ont démontré une amélioration significative de la survie sans récidive et de la survie globale dans ces populations de patients.

Traitement Néo-adjuvant

Le traitement néo-adjuvant, administré avant la chirurgie, est une stratégie émergente pour les mélanomes de stade III résécables. Il vise à réduire la taille de la tumeur et à contrôler les micrométastases avant l'intervention chirurgicale, potentiellement en améliorant les

taux de réponse pathologique complète et en facilitant la chirurgie. Les immunothérapies et les thérapies ciblées sont actuellement évaluées dans ce contexte.

Autres Modalités Thérapeutiques

Il est important de distinguer le traitement du mélanome invasif des traitements utilisés pour d'autres cancers cutanés, notamment les carcinomes cutanés. Des modalités telles que la cryothérapie, l'imiquimod topique, la photothérapie dynamique et le 5-fluoro-uracile topique sont des options thérapeutiques pour les carcinomes basocellulaires superficiels, les carcinomes épidermoïdes *in situ* (maladie de Bowen) ou les kératoses actiniques (Dermatologie, 2022). Cependant, ces traitements ne sont généralement pas indiqués pour le mélanome invasif en raison de son potentiel métastatique élevé et de la nécessité d'une exérèse complète avec analyse anatomopathologique (Dermatologie, 2022). Dans des cas très sélectionnés de mélanome *in situ* (lentigo maligna) chez des patients âgés ou non opérables, l'imiquimod ou la radiothérapie peuvent être envisagés, mais l'exérèse chirurgicale reste le traitement de référence (Dermatologie, 2022).

Suivi

Le suivi des patients atteints de mélanome est crucial et doit être régulier, adapté au stade initial de la maladie. Il vise à détecter précocement toute récidive locale, locorégionale ou à distance, ainsi que l'apparition d'un nouveau mélanome primaire. Il comprend des examens cliniques cutanés complets, des palpations ganglionnaires, et selon le stade, des examens d'imagerie (échographie ganglionnaire, scanner thoraco-abdomino-pelvien, IRM cérébrale, TEP-scanner).

Bibliographie

- Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed